NEDEĽNÁ METAFYZIKA / ETIKA / NEFROLÓGIA

Hranice medicíny

Pomoc, odmietnutie a zodpovednosť v život ohrozujúcej situácii

Metafyzika 5 | nedeľa 1. novembra 2026

Hranice medicíny

Do akej miery vieme pomôcť pacientovi, ktorý pomoc odmieta

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín. Pripravené pomocou rôznych aktuálnych nástrojov generatívnej umelej inteligencie a superinteligencie. Vydavateľ: MUDr. Ľubomír Polaščín - Nephroctor, IČO 57646856, DIČ 1047524401.

Nedeľná metafyzika, piaty diel | filozofická a klinicko-etická úvaha | nedeľa 1. novembra 2026

Text a pramene pripravené a overené 24. októbra 2026. Modelové situácie neoznačujú konkrétnych pacientov.

Lekár môže vedieť, ako odvrátiť smrť, a predsa nemať oprávnenie urobiť to. Vtedy sa neukazuje iba hranica medicíny, ale aj hranica našej moci nad druhým človekom.

Obsah

1. Hlavné zistenia
2. Prečo sa k hraniciam vraciame
3. Do akej miery vieme pacientovi pomôcť?
4. Kde sú hranice medicíny?
5. Autonómia a rozhodovacia spôsobilosť
6. Informovaný nesúhlas
7. Dokedy a do akej miery presviedčať?
8. Akútne zhoršenie: keď ide o život
9. Rodina: angažovať, ale nie prehlasovať
10. Konanie a nekonanie: metafyzika rovnakého výsledku
11. Pasívna eutanázia a trestnoprávne hranice
12. Dialýza: začať, nezačať, ukončiť, odmietnuť
13. Paliatívna starostlivosť a pokyny vopred
14. Lekár na hranici: únava, morálna úzkosť a svedomie
15. Metafyzické jadro: komu patrí život a čo je smrť pre medicínu
16. Rozhodovací kompas pri odmietnutí v akútnom zhoršení
17. Otázky na nedeľné premýšľanie
18. Záver: hranica ako miesto stretnutia
19. Slovníček pojmov
20. Pramene a poznámka k overeniu

1. Hlavné zistenia

Medicína má hranice na viacerých miestach naraz. Niektoré vyplývajú z toho, čo nevieme. Iné z toho, čo nedokážeme. Ďalšie z toho, čo nesmieme. Posledná hranica, konečnosť ľudského života, sa nedá posunúť žiadnym výskumom. Ak tieto vrstvy zlejeme do jednej vety „urobili sme všetko“ alebo „nedalo sa nič robiť“, stratíme presnosť práve tam, kde ju pacient potrebuje najviac.

Do akej miery vieme pacientovi pomôcť, nezávisí iba od indikácie a techniky. Závisí aj od toho, či pacient pomoc prijme, či jej dokáže porozumieť a či ju vôbec môže prijať v podmienkach, v ktorých žije. Pomoc je vzťah, nie výrobok, ktorý odovzdáme pri lôžku.

Pacienta, ktorý odmieta liečbu akútne zhoršeného stavu, máme presviedčať dovtedy, kým ďalší rozhovor prináša niečo nové: informáciu, úľavu, inú možnosť, obnovenú pozornosť alebo dôveru. Keď už prináša iba tlak, prestáva byť pomocou. Počet rozhovorov nie je morálne meradlo. Rozhoduje ich obsah.

Slovenské právo stojí na informovanom súhlase. Ohrozenie života samo súhlas nenahradí. Neodkladnú starostlivosť možno poskytnúť bez súhlasu iba vtedy, keď ho nemožno včas získať, ale možno ho predpokladať. Informované odmietnutie človeka schopného rozhodovať nie je situácia, v ktorej súhlas „nemožno získať“. Je to situácia, v ktorej bol súhlas odopretý.

Rodina je dôležitá, ale blízkosť nie je automatická právomoc. Príbuzní nemôžu za dospelého pacienta schopného rozhodovať ani súhlasiť, ani odmietať. Ich laxnosť či odmietnutie starostlivosti je najprv otázkou toho, čo reálne zvládnu, až potom otázkou charakteru. Iba v krajných prípadoch vstupuje do hry trestné právo.

Pojem „pasívna eutanázia“ je nepresný a v klinickej praxi skôr škodí. Zlepí dokopy rešpektovanie platného odmietnutia, ukončenie neprimeranej liečby, zanedbanie a úmyselné usmrtenie. Slovenské právo eutanáziu ani asistovanú samovraždu nepripúšťa. Pacientovo právo odmietnuť zdravotnú starostlivosť však zakotvuje výslovne. To sú dve odlišné veci a treba ich držať oddelene.

Lekár nesie zodpovednosť za kvalitu svojho postupu, nie za každý výsledok a nie za cudziu vôľu. Morálna úzkosť, ktorú pri takých situáciách zažíva, nie je slabosť ani profesionálne zlyhanie. Je to signál, ktorý si zaslúži pozornosť tímu aj inštitúcie.

Ako čítať tento diel

Piaty diel Nedeľnej metafyziky priamo nadväzuje na štvrtý diel „Hranice pomoci, autonómia a dôvera v medicíne“ (25. októbra 2026) a na článok „Ohrozenie života samo súhlas nenahradí“. Štvrtý diel sa sústredil na odvolanie súhlasu a na konflikt po popretí rozhovoru. Trestnoprávnu kvalifikáciu výslovne nechal bokom. Piaty diel ide tam, kde štvrtý zámerne zastal: k trestnoprávnym hraniciam, k dialýze a jej ukončeniu, k pokynom vopred, k únave lekára a k metafyzike konania a nekonania. Text nie je právnym stanoviskom ani liečebným protokolom. Modelové situácie neopisujú konkrétnych pacientov.

2. Prečo sa k hraniciam vraciame

2.1 Nedeľa medzi Všetkými svätými a Dušičkami

Tento diel je pripravený na nedeľu 1. novembra 2026, na sviatok Všetkých svätých. Nasledujúci deň patrí pamiatke zosnulých. Kalendár tak sám otvára tému, ktorej sa medicína rada vyhýba: smrť nie je iba udalosť na konci liečby, ale horizont, v ktorom sa celá liečba odohráva. Prvý diel série tvrdil, že metafyzika je hygiena mysle, bez ktorej sa aj najpraktickejšie disciplíny stávajú slepými voči vlastným základom. Pri hraniciach medicíny to platí doslova.

Lekár, ktorý sa nikdy nespýtal, čo znamená pomôcť, odpovedá na túto otázku aj tak. Odpovedá každým rozhodnutím o tom, či ešte volať, či ešte presviedčať, či ešte dialyzovať. Rozdiel je iba v tom, či odpovedá vedome.

2.2 Čo štvrtý diel povedal a čo nechal otvorené

Štvrtý diel [22] sformuloval nosnú tézu: keď sa skončí oprávnenie presadzovať určitú liečbu, nekončí sa povinnosť starať sa o človeka. Rozlíšil štyri hranice medicíny (poznania, účinnosti, oprávnenia a konečnosti), ukázal, že tvrdohlavosť je pomenovanie nášho zážitku a nie diagnóza, a navrhol postup pri akútnom konflikte. Pojem pasívnej eutanázie označil za nepresný, no jeho trestnoprávnu stránku nerozoberal.

Otvorené zostali najmä tieto otázky:

- Kde presne vedie slovenské trestné právo hranicu medzi rešpektovaním odmietnutia a neposkytnutím pomoci?
- Je etický rozdiel medzi tým, keď dialýzu nezačneme, a tým, keď ju ukončíme?
- Čo robiť s prianím, ktoré pacient vyslovil skôr, keď na Slovensku chýba podrobná zákonná úprava pokynov vopred?
- Aká je morálna povinnosť rodiny a kde sa končí?
- Čo robí s lekárom opakovaná skúsenosť, že pomôcť smie menej, než by vedel?
- Aký metafyzický rozdiel je medzi konaním a nekonaním, keď výsledok vyzerá rovnako?

2.3 Tri roviny a stupne istoty

Ako v predchádzajúcich dieloch, aj tu oddeľujeme tri roviny: filozofickú úvahu, klinicko-etické odporúčanie a slovenský právny rámec. Pri právnych tvrdeniach navyše používame postup, ktorý sa osvedčil v rešerši „O Čeresaroch“: odlišujeme to, čo je doložené priamo v texte prameňa, od rozumnej rekonštrukcie a od toho, čo zostáva otvorené.

Stupeň istoty	Čo znamená v tomto texte	Príklad
Výslovne v zákone	Ustanovenie platného predpisu, overené v časovej verzii účinnej k 24. 10. 2026	Právo kedykoľvek slobodne odvolať informovaný súhlas (§ 6 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z.)
Odôvodnený výklad	Záver, ktorý z textu rozumne vyplýva, ale súd ho výslovne nepotvrdil	Informované odmietnutie nie je situácia, v ktorej „nemožno včas získať“ súhlas
Otvorená otázka	Oblasť, v ktorej odborná literatúra pomenúva právnu neistotu	Záväznosť skôr vyslovených prianí pri chýbajúcej podrobnej úprave

2.4 Mapa otázok

Otázka	Prevažujúca rovina	Kapitola
Do akej miery vieme pacientovi pomôcť?	filozofická, klinická	3

Otázka	Prevažujúca rovina	Kapitola
Kde sú hranice medicíny?	filozofická	4
Kedy je pacient schopný rozhodovať?	klinická, právna	5
Čo musí obsahovať informovaný nesúhlas?	právna, etická	6
Dokedy a ako presviedčať?	etická	7
Čo mení akútne zhoršenie a strata vedomia?	právna, klinická	8
Ako zapojiť laxnú alebo odmietajúcu rodinu?	etická, právna	9
Je rozdiel medzi konaním a nekonaním?	metafyzická	10
Čo je pasívna eutanázia a kde sú trestnoprávne hranice?	právna, etická	11
Odmietnutie, nezačatie a ukončenie dialýzy	klinická, etická	12
Paliatívna starostlivosť a pokyny vopred	právna, klinická	13
Únava a morálna úzkosť lekára	etická, existenciálna	14
Komu patrí život a čo je smrť pre medicínu?	metafyzická	15

3. Do akej miery vieme pacientovi pomôcť?

3.1 Pomoc nie je iba zásah

Slovo pomoc znie jednoducho. V klinickej praxi sa však pod ním skrýva najmenej päť odlišných otázok. Dokážeme zasiahnuť? Prinesie zásah pravdepodobne prospech? Vyváži prospech záťaž? Zodpovedá zásah tomu, čo pacient od svojho života chce? A smieme ho vykonať? Štvrtý diel tieto otázky oddelil. Tu pridávame šiestu: dokáže pacient pomoc v podmienkach svojho života vôbec prijať a udržať?

Dialýza trikrát týždenne predpokladá dopravu, cievny prístup, ochotu znášať hodiny na lôžku a schopnosť zvládnuť obmedzenia v strave a tekutinách. Pre jedného pacienta je to nepríjemná, ale zvládnuteľná súčasť života. Pre iného je to každodenný zápas, ktorý mu berie práve to, kvôli čomu chcel žiť. Medicínska indikácia je pre oboch rovnaká. Pomoc nie.

3.2 Tri ciele medicíny

Stará lekárska maxima, ktorú tradícia pripisuje rôznym autorom, hovorí: niekedy vyliečiť, často uľaviť, vždy potešiť. Nie je to vedecké tvrdenie, ale presná mapa. Vyliečenie je v nefrológii skôr výnimkou ako pravidlom. Predĺženie života a úľava od ťažkostí sú bežným cieľom. Sprevádzanie je cieľom vždy, aj keď ostatné dva už nie sú dosiahnuteľné.

Zákon tento rozsah pozná. Zdravotná starostlivosť je podľa neho poskytnutá správne, ak smeruje k uzdraveniu osoby alebo k zlepšeniu jej stavu [1, § 4 ods. 3]. Paliatívnu starostlivosť vymedzuje ako starostlivosť o osobu s nevyliečiteľnou a progredujúcou chorobou, ktorej cieľom je zmierniť utrpenie a zachovať kvalitu života [1, § 2 ods. 39]. Medzi právami pacienta uvádza výslovne aj právo na zmiernenie utrpenia a na humánny, etický a dôstojný prístup [1, § 11 ods. 9 písm. g) a h)]. Pomoc teda nie je iba to, čo predlžuje život.

3.3 Čo znamená byť chorý

Prvý diel ukázal, že lekár, ktorý sa pýta „čo znamená, že niečo je choré“, už prevádzkuje metafyziku. Pri hraniciach pomoci sa táto otázka vracia v praktickej podobe. Ak je zdravie iba normálna hodnota laboratórneho parametra, pomôcť znamená vrátiť parameter do normy. Ak je zdravie schopnosť žiť život, ktorý človek považuje za svoj, pomôcť môže znamenať aj niečo iné.

Draslík 7,2 mmol/l je fakt. To, že ho treba znížiť, je silný odborný úsudok. To, že ho treba znížiť práve dialýzou, ktorú pacient odmieta, je už rozhodnutie, do ktorého vstupuje jeho vôľa. Aristotelovský rozdiel medzi substanciou a jej vlastnosťou, ktorý sme v prvom diele ilustrovali anúriou, tu dostáva etický rozmer: liečime vlastnosť, ale rozhoduje nositeľ.

> **Rozlíšenie**
>
> Medicínska indikácia hovorí, čo by pomohlo telu. Pomoc v plnom zmysle sa pýta, čo pomôže človeku, ktorý v tom tele žije. Tieto dve otázky sa väčšinou prekrývajú. Kde sa rozchádzajú, začína sa téma tohto spisu.

3.4 Kde sa naša pomoc dá merať

Pri hodnotení vlastného postupu sa oplatí oddeliť to, čo máme pod kontrolou, od toho, čo nie. Kvalita vysvetlenia, dostupnosť alternatív, liečba bolesti, bezpečný plán a presný záznam sú v našich rukách. Pacientovo rozhodnutie a konečný výsledok nie sú. Ak hodnotíme svoju pomoc

iba podľa výsledku, budeme sa cítiť vinní aj vtedy, keď sme postupovali správne, a spokojní aj vtedy, keď sme mali iba šťastie.

4. Kde sú hranice medicíny?

4.1 Päť vrstiev hranice

Štvrtý diel rozlíšil štyri hranice: poznania, účinnosti, oprávnenia a konečnosti. Pri hlbšej analýze sa ukazuje, že medzi ne patrí ešte jedna, ktorá sa v diskusiách často zamlčuje: hranica systému a zdrojov. Patrí sem aj hranica samotného lekára, o ktorej hovorí kapitola 14.

Hranica	Pôvod	Dá sa posunúť?	Typická chyba
Poznania	neistota prognózy a diagnózy	čiastočne, výskumom a lepším vyšetrením	istota tam, kde máme iba pravdepodobnosť
Účinnosti	biologické limity liečby	čiastočne, novými metódami	zámena fyziologického účinku za celkový prospech
Oprávnenia	právo a sloboda pacienta	nie zásahom lekára	presvedčenie, že odborná pravda dáva moc nad cudzím telom
Systému a zdrojov	doprava, kapacity, sociálne zázemie	áno, organizáciou a politikou	prenesenie zlyhania systému na pacienta alebo rodinu
Konečnosti	smrteľnosť človeka	nie	predlžovanie umierania ako dôkaz, že sme neprehrali

4.2 Hranica poznania: Kantova lekcia pri lôžku

Kant nepovedal, že metafyzika je nemožná. Povedal, že je možná ako mapovanie hraníc, za ktoré poznanie legitímne nesiaha. V klinickej medicíne platí podobná lekcia. Vieme pomenovať vysoké riziko, ale zriedka presný čas a výsledok. Poctivé poučenie preto znie inak než „určite zomriete“ aj inak než „možno to bude v poriadku“. Znie napríklad takto: „Bez dialýzy je vysoké riziko, že sa vám v najbližších hodinách až dňoch zastaví srdce. Nedokážem povedať kedy. Dokážem povedať, že dialýza toto riziko výrazne znižuje.“

4.3 Hranica oprávnenia: odborná pravda nie je moc

Lekár môže mať pravdu v tom, že výkon pomôže, a predsa ho nesmie vykonať. Táto veta je pre mnohých zdravotníkov ťažko stráviteľná, pretože naša profesionálna identita stojí na tom, že vieme a konáme. Zákon č. 576/2004 Z. z. však stavia vedľa seba dve povinnosti: poskytovať starostlivosť správne [1, § 4 ods. 3] a mať na ňu informovaný súhlas, ak zákon neustanovuje inak [1, § 4 ods. 4]. Prvá povinnosť druhú neprelamuje.

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne to formuluje ešte priamejšie: zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Súhlas môže kedykoľvek slobodne zrušiť [5, čl. 5]. Dohovor je ratifikovanou medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa Ústavy prednosť pred zákonmi [4, čl. 7 ods. 5].

4.4 Hranica systému: keď neodmieta pacient, ale život

Nie každé „nie“ je odmietnutím liečby. Niekedy je to odmietnutie podmienok, za ktorých sa liečba ponúka. Pacient, ktorý nemá kto odviezť na dialýzu, ktorý sa stará o chorú manželku alebo ktorý sa bojí, že po hospitalizácii stratí bývanie, môže povedať „nechcem“, hoci v skutočnosti myslí „nemôžem“. Ak túto vrstvu prehliadneme, pripíšeme pacientovi tvrdohlavosť, ktorá je v skutočnosti zlyhaním organizácie.

Medicína tu síce nemá moc vyriešiť všetko. Má však povinnosť pomenovať, čo by pomohlo, a spýtať sa, či sa to dá zabezpečiť. Sociálna práca, preprava, prechodné umiestnenie či kontakt s obcou nie sú luxusom. Často rozhodujú o tom, či sa odmietnutie zmení na súhlas.

4.5 Hranica konečnosti

Smrť môže byť následkom zanedbania. Nie každá smrť je však zlyhaním. Ak medicína chápe každé úmrtie ako porážku, začne predlžovať umieranie, aby nemusela priznať prehru. Štvrtý diel to vyjadril otázkou, či chránime pacientov život, alebo dokazujeme, že medicína ešte nestratila kontrolu. Pri hranici konečnosti sa táto otázka stáva najostrejšou.

> **Otázka na premýšľanie**
>
> Ktorú z piatich hraníc pociťujem vo svojej praxi najviac? A ktorú najčastejšie zamieňam za inú?

5. Autonómia a rozhodovacia spôsobilosť

5.1 Čo je autonómia a čo nie je

Autonómia nie je úplná nezávislosť od iných. Nikto nerozhoduje mimo tela, strachu, vzťahov a okolností. Autonómia je schopnosť a oprávnenie rozhodovať o sebe pri primeranej informovanosti, dobrovoľnosti a podpore. Druhý diel série ukázal, že kompatibilistické chápanie slobody zdôrazňuje konanie podľa vlastných dôvodov, bez relevantného donútenia a so schopnosťou reagovať na dôvody. Pre kliniku je toto chápanie užitočnejšie ako metafyzický spor o to, či je vesmír determinovaný. Nepotrebujeme vyriešiť Laplaceovho démona, aby sme posúdili, či pacient rozumie riziku.

5.2 Štyri schopnosti

V odbornej literatúre sa rozhodovacia spôsobilosť najčastejšie posudzuje podľa štyroch schopností, ktoré systematicky opísal Paul S. Appelbaum [16]. Britské odporúčanie NICE NG108 pracuje s príbuzným rámcom [12]. Nejde o slovenský zákonný test, ale o klinicky užitočnú štruktúru.

Schopnosť	Čo overujeme	Ako sa pýtať
Porozumieť	či pacient chápe svoj stav, navrhovaný výkon a riziká	„Povedzte mi vlastnými slovami, čo sa podľa vás deje s vašimi obličkami.“
Oceniť význam pre seba	či vzťahuje informácie na vlastnú situáciu	„Čo podľa vás znamená vysoký draslík pre vás, dnes a zajtra?“
Zvážiť	či dokáže porovnať možnosti a dôsledky	„Čo vám na dialýze prekáža najviac a čo by ste získali, keby ste ju podstúpili?“
Vyjadriť voľbu	či dokáže vysloviť stabilné rozhodnutie	„Ako ste sa teda rozhodli?“

Rozhodnutie môže byť nerozumné z pohľadu lekára a predsa byť výsledkom zachovanej spôsobilosti. Meradlo, ktoré za rozumné uzná iba súhlas s lekárom, by autonómiu priznávalo len tým, ktorí ju nikdy nepoužijú proti jeho odporúčaniu.

5.3 Posuvná škála a jej nebezpečenstvo

V bioetike sa diskutuje o tzv. posuvnej škále: čím závažnejší je možný následok rozhodnutia, tým dôkladnejšie má byť posúdenie spôsobilosti. Táto myšlienka má racionálne jadro. Nesúhlas s dialýzou pri hyperkaliémii si zaslúži dôkladnejšie overenie než nesúhlas s odberom krvi. Má však aj tienistú stránku. Ak požiadavky zvyšujeme dovtedy, kým ich nesplní nikto okrem súhlasiaceho pacienta, už neposudzujeme spôsobilosť. Hľadáme zdôvodnenie pre výsledok, ktorý sme si určili vopred.

Správne použitie posuvnej škály znamená väčšiu dôkladnosť, väčšiu podporu a presnejší záznam. Neznamená vyšší prah pre platnosť nesúhlasu ako pre platnosť súhlasu.

5.4 Slovenský právny rámec

Zákon č. 576/2004 Z. z. nehovorí o rozhodovacej spôsobilosti v klinickom zmysle. Rozlišuje osobu, ktorá dáva informovaný súhlas sama, a osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas, ktorou je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony [1, § 6 ods. 1 písm. b)]. Za takú osobu dáva súhlas zákonný zástupca, pričom osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti [1, § 6 ods. 6].

Medzera je zrejmá. Dospelý pacient v delíriu alebo pri uremickej encefalopatii nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, a predsa nemusí byť schopný rozhodnúť o dialýze. Zákon pre túto situáciu nemá osobitné ustanovenie o zástupcovi. Zostávajú výnimka pri neodkladnej starostlivosti [1, § 6 ods. 9 písm. a)], článok 6 a článok 8 Dohovoru [5] a odborný úsudok, ktorý musí byť dobre zdokumentovaný. Rodinný príslušník sa týmto stavom zákonným zástupcom nestáva.

5.5 Typické omyly

- Plynulá reč a orientácia ešte nedokazujú spôsobilosť rozhodnúť o konkrétnom výkone.
- Jasné „nie“ nevylučuje delírium.
- Diagnóza depresie, demencie či zlyhania obličiek sama osebe nedokazuje neschopnosť rozhodovať.
- Neschopnosť nemožno vyvodiť zo samotného nesúhlasu.
- Spôsobilosť sa môže v priebehu hodín meniť. Posúdenie platí pre konkrétny čas a konkrétne rozhodnutie.

> **Kontrolná otázka**
>
> Keby pacient s rovnakým stavom vedomia a rovnakými odpoveďami súhlasil, považoval by som jeho súhlas za platný? Ak áno, prečo by jeho nesúhlas mal byť neplatný?

6. Informovaný nesúhlas

6.1 Nesúhlas má rovnakú štruktúru ako súhlas

Informovaný súhlas je podľa zákona preukázateľný súhlas, ktorému predchádzalo poučenie [1, § 6 ods. 4]. Poučenie musí zahŕňať účel, povahu, následky a riziká starostlivosti, možnosti voľby a riziká odmietnutia [1, § 6 ods. 1]. Pacient má právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, keď ju zákon dovoľuje poskytnúť bez súhlasu [1, § 11 ods. 9 písm. d)]. Lisabonská deklarácia Svetovej lekárskej asociácie uznáva právo dospelého pacienta schopného rozhodovať súhlasiť s liečbou alebo ju odmietnuť [10].

Z toho vyplýva jednoduchá, ale často prehliadaná vec: platné odmietnutie si vyžaduje rovnako kvalitné poučenie ako platný súhlas. Pacient, ktorý odmieta dialýzu, musí vedieť, čo odmieta, čo mu hrozí a aké má iné možnosti. Ak to nevie, jeho „nie“ nie je informované. To však neznamená, že sa mení na „áno“. Znamená to, že poučenie treba doplniť.

6.2 Bez nátlaku a s dostatočným časom

Zákon ukladá poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť [1, § 6 ods. 2]. Pri akútnom zhoršení je „dostatočný čas“ krátky. Nie je však nulový. Aj desať pokojných minút s jedným hovoriacim lekárom môže znamenať viac ako hodina, počas ktorej sa pri lôžku striedajú traja zdravotníci s rovnakými argumentmi.

Pacient má aj právo poučenie odmietnuť [1, § 6 ods. 3]. O tom sa urobí písomný záznam. Odmietnutie poučenia neznamená automaticky odmietnutie výkonu ani súhlas s ním.

6.3 Čo patrí do záznamu

Zákon vyžaduje, aby spôsob a obsah poučenia, odmietnutie poučenia, súhlas, odmietnutie súhlasu aj jeho odvolanie boli súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie [1, § 6 ods. 10]. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník tieto skutočnosti zaznamenáva aj v elektronickej zdravotnej knižke [1, § 6 ods. 2]. Formulár, v praxi nazývaný negatívny reverz, je užitočný nástroj. Zákon však pre odmietnutie neustanovuje osobitnú podmienku podpisu pacienta. Ak pacient odmietne podpísať aj samotný reverz, povinnosť zaznamenať priebeh rozhovoru tým nezaniká a odmietnutie sa tým nestáva neplatným.

Prvok záznamu	Prečo je dôležitý
Dátum, čas, prítomné osoby	umožní neskôr rekonštruovať okolnosti
Klinický stav a jeho naliehavosť	ukáže, prečo išlo o závažné rozhodnutie
Obsah poučenia vrátane rizika smrti a alternatív	doloží, že odmietnutie bolo informované
Odpovede pacienta vlastnými slovami	doloží porozumenie lepšie ako veta „pacient poučený“
Zistenia o rozhodovacej spôsobilosti	oddelí nesúhlas od poruchy rozhodovania
Presný rozsah odmietnutia	ukáže, čo pacient prijíma
Dohodnutý ďalší postup a podmienky prehodnotenia	zabráni tomu, aby sa z odmietnutia stalo opustenie

6.4 Odmietnutie jedného nie je odmietnutím všetkého

Pacient môže odmietnuť zavedenie dialyzačného katétra do krčnej žily, a pritom súhlasiť s liečbou cez femorálny prístup. Môže odmietnuť hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti, a pritom súhlasiť s monitorovaním na štandardnom lôžku. Môže odmietnuť dialýzu, a pritom prijať lieky na zníženie draslíka, hoci ich účinok je dočasný. Presné vymedzenie toho, čo pacient odmieta, je prvým krokom ku každej ďalšej pomoci.

7. Dokedy a do akej miery presviedčať?

7.1 Presviedčanie, manipulácia, nátlak

Bioetická literatúra rozlišuje tri spôsoby, ktorými jeden človek ovplyvňuje rozhodnutie druhého [17]. Presviedčanie pôsobí cez dôvody: ponúka informácie a argumenty, ktoré môže druhý prijať alebo odmietnuť. Manipulácia obchádza rozum: zveličuje, zamlčuje, využíva strach alebo hanbu. Nátlak pracuje s hrozbou: ak nesúhlasíš, stratíš niečo, na čo máš nárok.

V prvom diele sme pri Hawkinsovom systéme pripomenuli rozlíšenie, ktoré obstojí aj vtedy, keď jeho metóda neobstojí: moc presviedča, sila donucuje. Pri lôžku je to rozdiel medzi lekárom, ktorý pacientovi pomáha uvidieť vlastnú situáciu jasnejšie, a lekárom, ktorý chce, aby pacient prestal odporovať. Prvý pôsobí na rozum a ponecháva slobodu. Druhý pôsobí na odpor a chce víťazstvo.

Legitímna vytrvalosť	Hranica nátlaku
jasné odporúčanie s pravdivým uvedením rizika smrti	strašenie istotou, ktorú nemáme
nový rozhovor s novým obsahom	opakovanie rovnakých viet až do vyčerpania
ponuka iného lekára alebo dôveryhodnej osoby	zástup autorít pri lôžku, ktorý vyvoláva pocit obkľúčenia
úľava od bolesti, dýchavice a strachu pred rozhovorom	podmieňovanie úľavy súhlasom
otázka, čo by liečbu urobilo prijateľnou	zahanbovanie, výčitky, morálne lekcie
zapojenie rodiny na želanie pacienta	použitie rodiny ako tlaku proti pacientovi
pomenovanie toho, čo bez súhlasu nemôžeme	vyhrážanie prepustením alebo stratou ďalšej starostlivosti

7.2 Kritérium nového obsahu

Štvrtý diel navrhol jednoduché pravidlo: presviedčať má zmysel, kým ďalší rozhovor môže zlepšiť porozumenie, posilniť slobodu rozhodovania alebo rozšíriť možnosti. Pri hlbšom pohľade sa dá toto pravidlo rozpísať do piatich zdrojov nového obsahu:

- **Nová informácia.** Zmenil sa klinický stav, výsledok, prognóza alebo dostupnosť alternatívy.
- **Nová podmienka.** Podarilo sa zabezpečiť dopravu, iný prístup, iné pracovisko, prítomnosť blízkej osoby.
- **Nový stav pacienta.** Ustúpila bolesť, dýchavica, horúčka či zmätenosť, ktoré mohli ovplyvniť rozhodovanie.
- **Nový hovoriaci.** Iný lekár, sestra, ktorej pacient dôveruje, duchovný alebo psychológ.
- **Nová otázka.** Namiesto „prečo nechcete“ sa spýtame „čo by sa muselo zmeniť, aby ste mohli súhlasiť“.

Ak žiadny z týchto zdrojov nie je k dispozícii, ďalší pokus nie je rozhovorom. Je tlakom.

7.3 Čas ako etická veličina

Pri akútnom zhoršení sa čas na presviedčanie zmenšuje. Hyperkaliémia nečaká na ďalší deň. Táto okolnosť vytvára pokušenie, aby sme naliehavosť stavu preniesli do naliehavosti nátlaku. Krátky čas však neznamená, že sa mení povaha rozhodnutia. Znamená, že treba skôr zvoliť najlepšieho hovoriaceho, skôr odstrániť bariéry a skôr presne zaznamenať, čo sa deje.

Krátky čas mení ešte jednu vec: zvyšuje význam dočasných opatrení, ktoré pacient prijme. Ak odmieta dialýzu, ale prijme lieky, monitorovanie a ďalší rozhovor o dve hodiny, získavame čas. Nie je to porážka. Je to priestor, v ktorom sa môže rozhodnutie zmeniť alebo upevniť.

7.4 Kedy prestať

Prestať presviedčať neznamená prestať sa starať. Znamená to zmeniť otázku. Z otázky „ako ho presvedčiť“ sa stáva otázka „čo z našej pomoci prijíma a ako ju poskytneme čo najlepšie“. Rozhodnutie sa môže znovu otvoriť, keď príde nová informácia alebo keď o to pacient požiada. Nemá sa z neho stať každodenný súboj o autoritu.

> **Dvojitá sebakontrola**
>
> Pred prijatím odmietnutia: Odstránili sme bariéry, ktoré sa dali odstrániť? Nezamieňame si únavu tímu za rešpekt k pacientovi? Pred ďalším presviedčaním: Prinesie rozhovor niečo nové? Nezamieňame si vlastnú potrebu úspechu za pacientovo dobro?

8. Akútne zhoršenie: keď ide o život

8.1 Neodkladnosť a jej dve podmienky

Zákon vymedzuje neodkladnú starostlivosť ako starostlivosť pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií, môže bez rýchleho poskytnutia vážne ohroziť zdravie, spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny správania, pod ktorých vplyvom osoba bezprostredne ohrozuje seba alebo okolie [1, § 2 ods. 3]. Ťažká hyperkaliémia, edém pľúc pri anúrii či urémia s poruchou vedomia do tohto vymedzenia spravidla spadajú.

Neodkladnosť však sama nestačí. Informovaný súhlas sa pri neodkladnej starostlivosti nevyžaduje, ak ho nemožno včas získať, ale ho možno predpokladať [1, § 6 ods. 9 písm. a)]. Obe podmienky musia byť splnené súčasne. Dohovor o biomedicíne hovorí o núdzových situáciách, keď v dôsledku núdze nie je možné získať zodpovedajúci súhlas [5, čl. 8]. Aj on teda predpokladá, že súhlas získať nemožno, nie že bol odopretý.

Tento bod je jadrom článku Ohrozenie života samo súhlas nenahradí, ktorý vyšiel 24. októbra 2026 ako komentár k štvrtému dielu [21]. Na tomto mieste ho rozvíjame do troch situácií, ktoré sa v praxi často zamieňajú.

Situácia	Možno súhlas včas získať?	Možno súhlas predpokladať?	Orientačný záver
Pacient v bezvedomí, žiadne známe prianie	nie	áno	výnimka podľa § 6 ods. 9 písm. a) sa spravidla uplatní
Spôsobilý pacient po poučení jasne odmieta	áno, a bol odopretý	nie	výnimku nemožno použiť; platí právo odmietnuť
Pacient odmietol, potom stratil vedomie	už nie	sporné; predchádzajúce odmietnutie hovorí proti predpokladu	treba posúdiť obsah, informovanosť a vzťah odmietnutia k aktuálnej situácii
Pacient v delíriu odmieta, známe prianie chýba	nie spoľahlivo	závisí od okolností	treba posúdiť príčinu, naliehavosť, primeranosť a právny základ

8.2 Keď pacient po odmietnutí stratí vedomie

Táto situácia je pre lekára azda najťažšia. Pacient pred hodinou jasne a po poučení odmietol dialýzu. Teraz je v bezvedomí a srdce sa spomaľuje. Zákon výslovne nehovorí, čo robiť. Rozumný výklad však vychádza z toho, že predpokladať súhlas nemožno tam, kde poznáme opačnú vôľu. Laciaková, Kováč a Moravanský upozorňujú, že pri chýbajúcej podrobnej úprave je lekár, ktorý rešpektuje skoršie odmietnutie, vystavený trestnoprávnej neistote [6].

Rozhodujúce sú tri otázky. Bolo odmietnutie informované a urobené pri zachovanej spôsobilosti? Týkalo sa práve tejto situácie, nielen všeobecne „nemocnice“ či „hadičiek“? A nezmenilo sa niečo podstatné, napríklad nová informácia, ktorú pacient pri odmietnutí nemal? Ak sú odpovede jasné a dobre zdokumentované, rešpektovanie odmietnutia je eticky obhájiteľné a zodpovedá aj článku 9 Dohovoru. Ak jasné nie sú, je pochopiteľné a obhájiteľné postupovať v prospech zachovania života. Pochybnosť však musí byť skutočná, nie vyrobená.

8.3 Paradox liečby, ktorá vracia schopnosť odmietnuť

Uremická encefalopatia vytvára zvláštnu situáciu. Dialýza môže zlepšiť práve tú schopnosť rozhodovať, ktorej nedostatok nám bráni rešpektovať pacientovo odmietnutie. Ak dialyzujeme

pacienta, ktorý ju v zmätenosti odmieta, a po dialýze nám jasne povie, že ju nechce, čo sme urobili? Zachránili sme jeho slobodu, alebo sme ju obišli?

Filozoficky ide o otázku, ktorej „ja“ máme byť verní. Druhý diel rozlišoval číselnú totožnosť od kvalitatívnej podobnosti: zmätený pacient a pacient po dialýze sú tá istá osoba, ale nie v rovnakom stave rozhodovania. Štvrtý diel varoval, aby sme si za „pravú“ nevyberali tú verziu pacienta, ktorá s nami súhlasí. Odpoveď preto nemôže byť automatická. Ak nevieme nič o jeho skoršej vôli a stav je neodkladný, zásah smerujúci k obnoveniu rozhodovacej schopnosti je eticky aj právne dobre obhájiteľný. Ak však poznáme jeho skoršie, informované a konkrétne odmietnutie, zmätenosť ho nevymaže. Zásah by v takom prípade neobnovoval jeho slobodu, ale prepisoval jeho rozhodnutie.

Samotná možnosť, že dialýza zlepší myslenie, nie je všeobecným oprávnením vykonať ju násilím. Fyzické obmedzenie kvôli somatickému výkonu je osobitný zásah. Potrebuje vlastné oprávnenie a jeho primeranosť treba posúdiť samostatne.

8.4 Duševná porucha nie je skratka

Zákon pozná výnimku pre osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu [1, § 6 ods. 9 písm. d)]. Pri prevzatí do ústavnej starostlivosti podľa tejto výnimky musí poskytovateľ do 24 hodín oznámiť prevzatie súdu a do jeho rozhodnutia možno vykonávať iba výkony nevyhnutné na záchranu života a zdravia alebo na zabezpečenie okolia [1, § 9 ods. 5]. Túto výnimku nemožno použiť iba preto, že pacient odmieta liečbu, ktorú považujeme za nevyhnutnú. Nesúhlas nie je príznakom duševnej poruchy.

> **Rozlíšenie**
>
> Naliehavosť vysvetľuje, prečo treba konať rýchlo. Sama osebe nevysvetľuje, prečo smieme konať proti vôli pacienta. Na to potrebujeme právny základ, nie iba medicínsky dôvod.

9. Rodina: angažovať, ale nie prehlasovať

9.1 Tri postavenia

Byť príbuzným, mať prístup k informáciám a byť oprávnený rozhodovať sú tri rôzne veci. Zákon umožňuje, aby pacient určil osobu, ktorú má lekár popri ňom poučiť [1, § 6 ods. 1 písm. a)]. Súhlas za pacienta dáva iba zákonný zástupca, a to iba ak ide o osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas [1, § 6 ods. 6]. Manžel, dcéra či syn dospelého pacienta týmto zástupcom automaticky nie sú.

Pre prax z toho vyplýva: ak je pacient schopný rozhodovať, rodina sa zapája podľa jeho želania a so zachovaním mlčanlivosti. Jej súhlas nenahrádza súhlas pacienta. Jej odmietnutie neruší pacientov súhlas.

9.2 Keď sa rodina stavia laxne

Laxnosť je pozorovanie, nie diagnóza. Za tým, že príbuzní neprídu, nedvíhajú telefón alebo odmietajú vziať pacienta domov, môže byť ľahostajnosť. Môže tam byť aj vyčerpanie, vlastná choroba, práca na zmeny, dlhodobo narušený vzťah, finančná tieseň alebo strach, že nezvládnu odbornú starostlivosť. Štúdia o generáciách zo 17. októbra 2026 pripomenula, že medzi generáciami prúdi rozsiahla pomoc vrátane opatrovania a že konflikty medzi nimi často nie sú konfliktmi hodnôt, ale rozdielnymi možnosťami. Rovnako je to pri lôžku.

Prvou otázkou preto nie je „prečo sa nestarajú“, ale „čo reálne zvládnu, čo nezvládnu a čo odmietajú“. Odpoveď má viesť ku konkrétnej dohode. Prísľub neurčitej pomoci nie je bezpečný plán prepustenia.

9.3 Do akej miery rodinu angažovať

Úroveň zapojenia	Kedy je vhodná	Hranica
Informovanie	ak s tým pacient súhlasí alebo osobu určil	mlčanlivosť voči ostatným
Podpora rozhodovania	pacient chce mať blízkych pri rozhovore	rodina nehovorí za pacienta
Sprostredkovanie hodnôt	pacient nemôže rozhodovať a treba zistiť jeho skoršiu vôľu	rodina opisuje pacientove hodnoty, nie vlastné želania
Praktická starostlivosť	doprava, dohľad, domáca pomoc	iba v rozsahu, ktorý príbuzní reálne a dobrovoľne prevezmú
Rozhodovanie	iba zákonný zástupca pri osobe nespôsobilej dať súhlas	pri odmietnutí zástupcu môže poskytovateľ podať návrh na súd (§ 6 ods. 7)

Ak zákonný zástupca odmietne dať súhlas, poskytovateľ môže podať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať súhlas. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať iba výkony nevyhnutné na záchranu jej života [1, § 6 ods. 7]. Toto ustanovenie sa netýka dospelého pacienta schopného rozhodovať.

9.4 Keď rodina starostlivosť úplne odmieta

Človek má morálne dôvody nebyť ľahostajný k svojim blízkym. Z morálneho vzťahu však automaticky nevzniká neobmedzená povinnosť osobnej starostlivosti ani rozhodovacia právomoc. Lekár nemôže rodinu donútiť, aby si pacienta vzala domov. Môže a má pomenovať, čo pacient potrebuje, a ak to rodina nezabezpečí, hľadať iné riešenie cez sociálnu prácu, následnú či dlhodobú starostlivosť alebo zariadenie sociálnych služieb.

Trestné právo vstupuje až na okraji. Zanedbanie povinnej výživy postihuje toho, kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného [2, § 207]. Týranie blízkej osoby a zverenej osoby zahŕňa aj bezdôvodné odopieranie nevyhnutnej osobnej starostlivosti či zdravotnej starostlivosti blízkej osobe alebo osobe v starostlivosti páchateľa [2, § 208 ods. 1 písm. b)]. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka ukladá oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta [3]. Tieto ustanovenia sú krajnou hranicou, nie nástrojom na zvýšenie tlaku na nespolupracujúcich príbuzných.

> **Praktický cieľ**
>
> Nie vynútený prejav rodinnej oddanosti, ale uskutočniteľná starostlivosť, jasné úlohy, bezpečný plán pri zhoršení a pomenovanie toho, čo musí prevziať systém, keď to rodina nezvládne.

9.5 Rodina proti pacientovi a pacient proti rodine

Niekedy rodina chce „všetko“, hoci pacient nechce. Inokedy pacient chce liečbu, ale rodina naznačuje, že by to „nemalo zmysel“. V oboch prípadoch platí rovnaké pravidlo: rozhoduje pacient, ak je schopný rozhodovať. Ak nie je, rozhodujúcim meradlom je jeho známa vôľa a jeho prospech, nie želanie príbuzných. Samostatný rozhovor s pacientom bez rodiny je vhodný vždy, keď je podozrenie na tlak. Časová súvislosť medzi návštevou a zmenou postoja ešte nedokazuje donucovanie. Pacient mohol od blízkych dostať aj podstatnú informáciu alebo odvahu.

10. Konanie a nekonanie: metafyzika rovnakého výsledku

10.1 Problém

Pacient zomrie po tom, čo sme nezačali dialýzu. Iný pacient zomrie po tom, čo sme dialýzu ukončili. Tretí zomrie po tom, čo mu niekto podal smrtiacu látku. Výsledok je vo všetkých troch prípadoch rovnaký. Intuícia nám hovorí, že morálne rovnaké nie sú. Je táto intuícia oprávnená, alebo je to iba psychologická úľava?

James Rachels v známom článku z roku 1975 tvrdil, že samotný rozdiel medzi zabitím a nechaním zomrieť nemá morálnu váhu [20]. Jeho argument je silný proti pohodlnému presvedčeniu, že nekonanie je vždy nevinné. Nevyvracia však rozdiely, ktoré sú medzi uvedenými prípadmi skutočne prítomné: rozdiel v povinnosti, v oprávnení, v úmysle a v príčine.

10.2 Príčina: čo zabíja?

Aristotelovská tradícia, z ktorej vychádzal prvý diel, rozlišuje viac druhov príčin. Pri nezačatí či ukončení dialýzy je príčinou smrti zlyhanie obličiek, teda choroba, ktorú medicína prestala kompenzovať. Pri podaní smrtiacej látky je príčinou smrti tá látka. Toto rozlíšenie nie je slovná hra. Hovorí, čo sa vo svete udialo. V prvom prípade lekár prestal zadržiavať proces, ktorý už bol v tele prítomný. V druhom prípade vniesol do sveta novú príčinu smrti.

Námietka znie: aj keď proces bol prítomný, lekár ho mohol zastaviť. Tu vstupuje druhé kritérium.

10.3 Oprávnenie: smiem?

Ak pacient platne odmietol dialýzu, lekár ju nesmie vykonať. Jeho nekonanie preto nie je voľbou medzi dvoma dovolenými možnosťami. Je to rešpektovanie hranice, za ktorú nesmie ísť. Ak by ju prekročil, zasiahol by do telesnej integrity, ktorú chráni Ústava [4, čl. 16] aj zákon [1, § 11 ods. 9 písm. a)]. Nekonanie z dôvodu chýbajúceho oprávnenia má inú morálnu štruktúru ako nekonanie z nedbanlivosti alebo pohodlnosti.

10.4 Úmysel: čo chcem?

Pri rešpektovaní odmietnutia nie je smrť cieľom lekára ani prostriedkom, ktorým by niečo dosahoval. Lekár by bol rád, keby pacient žil. Pri eutanázii je smrť zvoleným prostriedkom na ukončenie utrpenia. Princíp dvojitého účinku, ktorý sa v etike používa pri tlmení bolesti a dýchavice, stojí na tom istom rozlíšení: predvídaný, ale nechcený následok sa morálne posudzuje inak ako zamýšľaný cieľ. Úmysel nemožno iba vyhlásiť. Musí sa ukázať v postupe: v indikácii, dávkovaní, sledovaní a zázname.

10.5 Nezačať a ukončiť

Mnohí lekári vnímajú ukončenie liečby ako ťažšie než jej nezačatie. Psychologicky je to pochopiteľné. Ukončenie je viditeľný krok, nezačatie sa stratí v tichu. Eticky sa však v odbornej literatúre prevažne uznáva, že ak liečba už nezodpovedá svojmu cieľu alebo ju pacient platne odmieta, jej ukončenie možno odôvodniť rovnako ako jej nezačatie [9, 13]. Opačný názor má nebezpečný dôsledok: ak by sa liečba po začatí nedala ukončiť, lekári by sa báli ju vôbec začať. Časovo ohraničená skúška liečby by stratila zmysel.

To neznamená, že ukončenie je bez ťarchy. Vyžaduje dôkladnejšiu prípravu, jasnú komunikáciu s rodinou, plán liečby príznakov a citlivosť k tomu, že pre blízkych je to iný zážitok. Ide o rozdiel v spôsobe, nie v morálnej prípustnosti.

Päť otázok namiesto jednej nálepky

Aký výkon sa nezačal alebo ukončil? Aká bola indikácia? Aká bola vôľa pacienta? Aký bol zámer konania? Aká starostlivosť pokračuje?

11. Pasívna eutanázia a trestnoprávne hranice

11.1 Prečo je pojem nepresný

Pojem pasívna eutanázia sa v slovenskej diskusii používa pre veľmi rôzne situácie: pre rešpektovanie odmietnutia, pre ukončenie neúčelnej liečby, pre rozhodnutie neresuscitovať a niekedy aj pre zanedbanie. Svetová lekárska asociácia vymedzuje eutanáziu ako úmyselné podanie smrtiacej látky alebo vykonanie zásahu, ktorým lekár spôsobí smrť pacienta schopného rozhodovať, na jeho dobrovoľnú žiadosť. Výslovne uvádza, že lekár, ktorý rešpektuje právo pacienta odmietnuť liečbu, nekoná neeticky, aj keď po odmietnutí nastane smrť [8]. Podľa tohto vymedzenia rešpektovanie odmietnutia eutanáziou nie je.

11.2 Čo hovorí slovenské právo výslovne

Ústava zaručuje každému právo na život a ustanovuje, že nikto nesmie byť pozbavený života. Súčasne uvádza, že nejde o porušenie práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné [4, čl. 15].

Trestný zákon nepozná osobitnú skutkovú podstatu usmrtenia na žiadosť. Úmyselné usmrtenie iného je trestným činom vraždy [2, § 145], pri vopred uváženej pohnútke úkladnej vraždy [2, § 144]. Súhlas poškodeného nevylučuje protiprávnosť činu, ktorý smeruje proti životu alebo zdraviu poškodeného. Výnimkou je súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ktorá bola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi a so súčasnými poznatkami lekárskej vedy a praxe [2, § 29 ods. 1]. Kto iného pohne k samovražde alebo mu k nej pomáha, ak došlo aspoň k pokusu, dopúšťa sa trestného činu účasti na samovražde [2, § 154].

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohu č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z., ustanovuje, že zdravotnícky pracovník u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich zmierňuje bolesť, rešpektuje ľudskú dôstojnosť a priania pacienta v súlade s právnymi predpismi a zmierňuje utrpenie. Hneď nato uvádza: „Eutanázia a asistované suicidium sú neprípustné.“ [3] Ten istý kódex zakazuje ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné či iné výkony [3].

Proti tomu stojí výslovné právo pacienta odmietnuť zdravotnú starostlivosť [1, § 11 ods. 9 písm. d)] a právo kedykoľvek slobodne odvolať súhlas [1, § 6 ods. 8].

11.3 Kde je právna neistota

Neposkytnutie pomoci postihuje toho, kto osobe v nebezpečenstve smrti alebo s príznakmi ťažkej ujmy na zdraví neposkytne potrebnú pomoc. Prísnejšie postihuje toho, kto je na to povinný podľa povahy svojho zamestnania [2, § 177 ods. 2]. Slovenská odborná literatúra opakovane upozorňuje, že lekár, ktorý rešpektuje predchádzajúce prianie pacienta, môže byť v praxi vystavený riziku trestného stíhania podľa tohto ustanovenia a že chýbajúca podrobná úprava spôsobuje neistotu [6]. Ministerstvo zdravotníctva podľa správy STVR z apríla 2026 zmenu tejto úpravy neplánovalo [7].

Odôvodnený výklad, ktorý tu predkladáme ako argument, nie ako rozsudok, znie takto. Pomoc, ktorú pacient schopný rozhodovať po poučení platne odmietol, nemožno poskytnúť bez porušenia jeho práva podľa § 11 ods. 9 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. a článku 5 Dohovoru. Ak ju lekár neposkytne, koná v rámci svojej zákonnej povinnosti rešpektovať odmietnutie. Trestný zákon pozná okolnosť vylučujúcu protiprávnosť pri výkone práva a povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného predpisu [2, § 28]. Ani tento výklad však neodstraňuje potrebu dôkladného poučenia, overenia spôsobilosti a presného záznamu. Práve tie robia z nekonania rešpektovanie hranice, a nie neposkytnutie pomoci.

11.4 Orientačná mapa situácií

Tabuľka nie je právnou kvalifikáciou. Tú môžu urobiť iba orgány činné v trestnom konaní a súd. Má ukázať, že rovnaký výsledok môže mať veľmi odlišnú etickú a právnu povahu. Skratka TZ v nej označuje Trestný zákon.

Situácia	Etické pomenovanie	Právna rovina (orientačne)
Spôsobilý pacient po poučení odmietne dialýzu, lekár ju nevykoná a pokračuje v inej starostlivosti	rešpektovanie informovaného odmietnutia, nie eutanázia	právo odmietnuť podľa § 11 ods. 9 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z.; podmienkou je poučenie a záznam
Liečba nemôže dosiahnuť odôvodnený cieľ alebo jej záťaž je neprimeraná; nezačne sa alebo sa ukončí	obmedzenie neprimeranej liečby	Etický kódex zakazuje neúčelné výkony; nutné je odborné odôvodnenie a komunikácia
Lekár neposkytne potrebnú a prijímanú pomoc z ľahostajnosti alebo omylom	zanedbanie	možné neposkytnutie pomoci (§ 177 TZ), usmrtenie z nedbanlivosti (§ 149 TZ)
Primerane titrovaná liečba bolesti a dýchavice v závere života	paliatívna liečba, princíp dvojitého účinku	zmiernenie utrpenia ako právo pacienta (§ 11 ods. 9 písm. g); postup lege artis
Úmyselné podanie smrtiacej látky na žiadosť pacienta	eutanázia	Etický kódex ju vylučuje; súhlas nevylučuje protiprávnosť (§ 29 TZ); možná vražda (§ 145 TZ)
Poskytnutie prostriedku, ktorým si pacient sám spôsobí smrť	asistovaná samovražda	Etický kódex ju vylučuje; účasť na samovražde (§ 154 TZ)

11.5 Medzinárodný kontext

Európsky súd pre ľudské práva v rozsudku Pretty proti Spojenému kráľovstvu (2002) uviedol, že z práva na život nemožno odvodiť právo zomrieť a že zákaz asistovanej samovraždy Dohovor neporušuje. V rozsudku veľkej komory Lambert a ďalší proti Francúzsku (2015) súd nekonštatoval porušenie práva na život pri ukončení umelej výživy a hydratácie, pretože Francúzsko malo jasný právny rámec a dôkladný rozhodovací proces [11]. Obe rozhodnutia ukazujú to isté: štáty majú pri koncových rozhodnutiach širokú voľnosť, no pri ukončení liečby sa vyžaduje jasný postup. Na Slovensku podrobný postup pre koncové rozhodnutia chýba [6, 7]. Ťarcha preto dopadá na kvalitu rozhodovania v jednotlivom prípade.

> **Rozlíšenie**
>
> Slovenské právo eutanáziu nepripúšťa. Slovenské právo pacientovi priznáva právo odmietnuť liečbu. Kto tieto dve vety zlúči do jednej, buď začne nútiť pacientov do liečby, alebo začne nazývať rešpekt zabíjaním.

12. Dialýza: začať, nezačať, ukončiť, odmietnuť

12.1 Dialýza ako prípad, na ktorom sa hranice ukazujú najostrejšie

Dialýza je v istom zmysle ideálnym príkladom hraníc medicíny. Je vysoko účinná pri odstraňovaní život ohrozujúcich porúch vnútorného prostredia. Zároveň je to celoživotná, časovo náročná liečba, ktorá zasahuje do každého dňa. Pri akútnom zhoršení dokáže v priebehu hodín odvrátiť smrť. Pri chronickom zlyhaní obličiek u krehkého, polymorbídneho seniora však nemusí predĺžiť život v takej miere ani v takej kvalite, akú si pacient predstavuje.

Preto pri dialýze nemožno odpovedať jednou vetou na otázku „pomôže?“. Treba sa pýtať, komu, v akom stave, na ako dlho a za akú cenu.

12.2 Konzervatívna liečba nie je „nič nerobiť“

Medzinárodná pracovná skupina Medzinárodnej nefrologickej spoločnosti (ISN) vymedzila konzervatívnu liečbu zlyhania obličiek ako aktívnu starostlivosť zameranú na kvalitu života, ktorá nezahŕňa dialýzu ani transplantáciu. Jej jadrom je podporná nefrologická starostlivosť: spoločné rozhodovanie, liečba príznakov, plán pri krízach, plánovanie starostlivosti vopred, duchovná podpora, starostlivosť o umierajúceho a podpora pozostalých [15]. Odporúčanie KDIGO 2024 pre chronickú chorobu obličiek uvádza, že dialýzu treba začať na základe súhrnného posúdenia príznakov, nálezov, kvality života, preferencií pacienta, úrovne glomerulovej filtrácie a laboratórnych odchýlok [14].

Pre tému tohto spisu je to podstatné. Pacient, ktorý odmieta dialýzu, nemusí odmietať starostlivosť. Nefrológ, ktorý ponúkne konzervatívnu liečbu, neopúšťa pacienta. Ponúka mu inú cestu, ktorá je v mnohých krajinách súčasťou bežného portfólia nefrologickej starostlivosti.

12.3 Časovo ohraničená skúška

Pri neistej prognóze možno so súhlasom pacienta ponúknuť časovo ohraničenú skúšku dialýzy. Vopred treba dohodnúť cieľ, dĺžku a spôsob prehodnotenia. Odporúčania Renal Physicians Association tento postup opisujú [13]. Skúška má zmysel iba vtedy, ak je z nej možné vystúpiť. Ak by sa ukončenie po skúške bralo ako zlyhanie alebo ako nedovolený krok, skúška by sa zmenila na pascu.

12.4 Modelové situácie

Štvrtý diel opísal tri situácie: účinnú dialýzu a informované odmietnutie, odmietanie pri delíriu a neistý prospech a súhlas so skúškou liečby. Nasledujúce situácie ich dopĺňajú. Sú modelové a neopisujú konkrétnych pacientov.

D. Dlhodobo dialyzovaný pacient chce ukončiť liečbu. Sedemdesiatosemročný muž je osem rokov na hemodialýze. Má pokročilé srdcové zlyhanie, amputáciu dolnej končatiny a opakované infekcie cievneho prístupu. Hovorí, že už nechce chodiť na dialýzu. Rozhodovaciu spôsobilosť má zachovanú, depresiu psychiater nepotvrdil. V tejto situácii nejde o eutanáziu ani o samovraždu. Ide o odmietnutie ďalšej liečby, ktorú má pacient právo odmietnuť. Úlohou tímu je overiť, či rozhodnutie nevychádza z liečiteľnej príčiny (bolesť, depresia, sociálna izolácia, problém s dopravou), ponúknuť skúšobnú úpravu režimu, ak by ju pacient prijal, a ak trvá na ukončení, zabezpečiť paliatívnu starostlivosť, liečbu príznakov a prítomnosť blízkych. Rozhodnutie nemusí byť definitívne. Pacient ho môže zmeniť.

E. Senior s demenciou a rodina, ktorá „nechce nič“. Osemdesiatdeväťročná pacientka s pokročilou demenciou má akútne zlyhanie obličiek pri dehydratácii a sepse. Sama rozhodovať nemôže. Zákonného zástupcu nemá. Dcéra hovorí, že „mama by nič také nechcela“, ale nevie

uviesť konkrétny výrok. Syn žiada „všetko“. Rodina tu nerozhoduje, ale môže pomôcť zistiť pacientkine hodnoty. Ak nie je známe jej konkrétne prianie, lekár postupuje podľa jej prospechu a primeranosti liečby: rehydratácia a antibiotiká môžu byť jednoznačne primerané, zatiaľ čo zavedenie dlhodobej dialýzy pri jej celkovom stave nemusí. Rozhodnutie o neprimeranosti je odborné, nie rodinné. Treba ho odôvodniť, zdokumentovať a ideálne konzultovať s ďalším lekárom.

F. Pacient odmieta katéter, nie dialýzu. Päťdesiatdvaročný muž s ťažkou hyperkaliémiou odmieta zavedenie centrálneho katétra, pretože pred rokmi zažil komplikáciu. Dialýzu ako takú neodmieta. Nesúhlas sa týka konkrétneho výkonu. Úlohou je hľadať alternatívny prístup, iného operatéra, lepšiu analgéziu alebo sedáciu, s ktorou súhlasí. Ak by sme jeho nesúhlas zapísali ako „odmieta dialýzu“, zlyhali by sme v presnosti a možno aj v pomoci.

G. Pacient opakovane odchádza z dialýzy predčasne. Šesťdesiatročná pacientka si pravidelne skracuje dialýzu o hodinu a pol. Má opakované epizódy hyperkaliémie a preťaženia tekutinami. Nehovorí, prečo. Tu nejde o jednorazové odmietnutie, ale o vzorec. Treba hľadať dôvod: kŕče, hypotenzia, svrbenie, bolesť chrbta, rodinné povinnosti, depresia. Treba hľadať aj to, čo sa dá zmeniť: dĺžku, frekvenciu, režim, inkrementálny prístup, domácu dialýzu. Moralizovanie nepomôže. Pomôže zistenie, čo pacientka v skutočnosti odmieta.

12.5 Čo sa deje po ukončení dialýzy

Pacient aj rodina sa pýtajú, čo nastane. Poctivá odpoveď znie, že priebeh je individuálny a závisí od zvyškovej funkcie obličiek, od pridružených chorôb a od príjmu tekutín. Nemožno sľúbiť presný čas. Možno sľúbiť, že príznaky ako dýchavica, nevoľnosť, svrbenie, nepokoj a bolesť budeme aktívne liečiť a že pacient nezostane sám. Práve tento sľub odlišuje ukončenie liečby od opustenia pacienta.

> **Nefrologické rozlíšenie**
>
> Odmietnutie účinnej liečby, porucha rozhodovania a neprimeranosť liečby sú tri odlišné problémy. Môžu sa prekrývať, ale nesmú sa zamieňať. Konzervatívna liečba je štvrtou možnosťou, nie prázdnym miestom medzi nimi.

13. Paliatívna starostlivosť a pokyny vopred

13.1 Paliatívna starostlivosť v slovenskom zákone

Paliatívna zdravotná starostlivosť je v zákone vymedzená ako starostlivosť o osobu s nevyliečiteľnou a progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k jej smrti, s cieľom zmierniť utrpenie a zachovať kvalitu života [1, § 2 ods. 39]. Zákon ju delí na základnú, ktorú poskytuje lekár iného odboru, a špecializovanú, ktorú poskytuje lekár so špecializáciou v paliatívnej medicíne. Jej súčasťou je aj krízová intervencia pre pacienta a blízku osobu, a to aj po úmrtí pacienta [1, § 10e].

Zákon ukladá ošetrujúcemu lekárovi osobitnú povinnosť poučenia. Ak zistí nevyliečiteľnú a progredujúcu chorobu a rozhodne o potrebe paliatívnej starostlivosti, musí pacienta informovať aj o vyčerpaní možností dostupnej liečby, ktorá by odvrátila progresiu, o možnosti paliatívnej starostlivosti a o možnosti sociálnej pomoci alebo duchovnej služby [1, § 6ba]. Pacient má právo na duchovnú službu v zdravotníckom zariadení [1, § 11 ods. 9 písm. i)].

13.2 Paliatívny nie je trest

Paliatívny prístup patrí každému, kto trpí, aj pacientovi, ktorý pokračuje v aktívnej liečbe. Odmietnutie účinného výkonu však samo osebe nedokazuje, že je choroba terminálna. Bolo by neprijateľné označiť pacienta za paliatívneho iba preto, že s nami nespolupracuje. Rovnako neprijateľné by bolo odoprieť mu paliatívnu starostlivosť preto, že odmietol to, čo sme mu ponúkli predtým.

13.3 Paliatívna sedácia

Benátska deklarácia Svetovej lekárskej asociácie opisuje hlbokú sedáciu v závere života ako krajnú možnosť pri závažných a inak nezvládnuteľných príznakoch, so súhlasom a s dokumentáciou [9]. Sedácia smeruje k úľave, nie k odstráneniu nesúhlasu. Odmietnutie dialýzy nie je samo osebe indikáciou na sedáciu. Nepriateľské správanie nie je dôvodom na paliatívnu sedáciu vôbec. Sedácia, ktorá má umožniť výkon, ktorému sa pacient bráni, je iná otázka a potrebuje samostatné oprávnenie.

13.4 Pokyny vopred: čo platí a čo chýba

Dohovor o biomedicíne ustanovuje: „U pacienta, ktorý v čase zákroku nie je v takom stave, že môže vyjadriť svoje prianie, treba prihliadať na prianie, ktoré vyslovil s vykonaním zákroku skôr“ [5, čl. 9]. Dohovor má ako ratifikovaná medzinárodná zmluva prednosť pred zákonmi [4, čl. 7 ods. 5].

Slovenská vnútroštátna úprava však podrobnosti neupravuje. Nevymedzuje formu, platnosť, obnovovanie, register ani záväznosť pokynov vopred. Na túto medzeru upozorňuje odborná literatúra najmenej od roku 2017 [6] a podľa správy STVR zo 7. apríla 2026 ministerstvo zdravotníctva zmenu v tom čase neplánovalo [7]. Rovnako chýba osobitná zákonná úprava rozhodnutia neresuscitovať.

Otázka	Stav k 24. 10. 2026	Stupeň istoty
Treba prihliadať na skôr vyslovené prianie?	áno, čl. 9 Dohovoru	výslovne v predpise
Je prianie automaticky záväzné za každých okolností?	nie; „prihliadať“ neznamená bezvýhradne splniť	odôvodnený výklad, zhodný s literatúrou
Existuje slovenská úprava formy a registra pokynov vopred?	nie	doložené literatúrou a správou STVR

Otázka	Stav k 24. 10. 2026	Stupeň istoty
Je upravené rozhodnutie neresuscitovať?	osobitnou zákonnou úpravou nie	doložené literatúrou
Možno spísané prianie použiť ako doklad známej vôle?	áno, ako významný doklad pri posúdení	odôvodnený výklad

13.5 Plánovanie starostlivosti vopred ako proces

Pokyn vopred je dokument. Plánovanie starostlivosti vopred je rozhovor, ktorý sa opakuje. Pre nefrológiu je to prirodzená súčasť práce: pacient s pokročilou chorobou obličiek by mal mať možnosť hovoriť o svojich hodnotách, obavách a hraniciach skôr, než príde akútna kríza. Ak sa o tom hovorí v pokoji, v ambulancii, za prítomnosti blízkych, ktorých si pacient zvolí, vzniká záznam, ktorý neskôr pomôže pri rozhodovaní oveľa viac ako formulár nájdený v taške na urgentnom príjme.

Aj bez osobitnej zákonnej úpravy možno zaznamenať do dokumentácie, čo pacient chce a čo nechce, za akých okolností, s akými informáciami a kedy. Takýto záznam nie je právne bezchybnou zárukou. Je však najlepším dostupným dokladom jeho vôle.

> **Praktická poznámka**
>
> Najužitočnejší pokyn vopred nie je ten najdlhší, ale ten najkonkrétnejší: čo pacient odmieta, v akej situácii, s akým pochopením dôsledkov, kedy to povedal a komu.

14. Lekár na hranici: únava, morálna úzkosť a svedomie

14.1 Morálna úzkosť

Andrew Jameton v roku 1984 opísal morálnu úzkosť ako stav, keď človek vie, čo by bolo správne urobiť, ale vonkajšie obmedzenia mu to znemožňujú [18]. Pôvodný opis vychádzal z ošetrovateľstva; dnes sa používa pre všetky zdravotnícke profesie. Epsteinová a Hamricová doplnili, že po každej takej skúsenosti zostáva morálne reziduum a že sa pri opakovaní hromadí. Nazvali to efektom crescenda [19].

Lekár, ktorý rešpektuje odmietnutie dialýzy a potom vidí pacienta zomierať, môže prežívať presne tento stav. Vie, čo by pomohlo. Vie aj, že to nesmie urobiť. Obe vedomosti sú pravdivé a nedajú sa zmieriť jednou vetou. Táto bolesť nie je dôkazom pochybenia. Je dôkazom, že lekárovi záleží.

14.2 Únava a súcitové vyčerpanie

Opakované konflikty, nočné služby a pacienti, ktorí popierajú rozhovory, vyčerpávajú. Vyčerpaný lekár má dve pokušenia. Prvé je ustúpiť príliš skoro a nazvať to rešpektom. Druhé je tlačiť príliš dlho a nazvať to starostlivosťou. Oba omyly majú rovnaký zdroj: potrebu, aby sa nepríjemná situácia skončila. Štvrtý diel to zhrnul otázkou, či si nezamieňame únavu tímu za rešpekt k pacientovi.

Riešením nie je osamelé hrdinstvo. Riešením je rozdelenie úloh, prizvanie kolegu, krátka porada v tíme po náročnej udalosti a systém, ktorý neočakáva bezhraničnú odolnosť jednotlivca.

14.3 Výhrada svedomia

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka uvádza, že od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak výhradu uplatní, musí o tom informovať zamestnávateľa a pri poskytovaní starostlivosti aj pacientov [3]. Výhrada svedomia teda chráni lekára pred tým, aby musel konať proti svojmu presvedčeniu. Nedáva mu však právo vnútiť svoje presvedčenie pacientovi ani ho opustiť bez zabezpečenia inej pomoci.

14.4 Zodpovednosť bez všemocnosti

Epiktétos začína svoju príručku rozlíšením toho, čo je v našej moci, od toho, čo v našej moci nie je. Pre lekára na hranici je to užitočná, hoci nepohodlná múdrosť. V našej moci je kvalita vysvetlenia, pravdivosť, dostupnosť alternatív, liečba príznakov, bezpečný plán a presný záznam. V našej moci nie je pacientova vôľa, priebeh choroby ani konečný výsledok. Kto sa zodpovedá za všetko, nakoniec sa nezodpovedá za nič konkrétne.

Gurdjieffova požiadavka seba-pozorovania, ktorú sme spomenuli v prvom diele, sa tu dá preložiť do praktickej otázky: čo vo mne práve teraz chce, aby pacient súhlasil? Je to jeho dobro, alebo moja potreba mať pravdu, ukončiť konflikt, vyhnúť sa výčitke? Lekár, ktorý si túto otázku dokáže položiť, sa stáva slobodnejším voči vlastným motívom.

14.5 Etická konzultácia a etická komisia

Zákon počíta s tým, že etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti posudzuje nezávislá etická komisia [1, § 5]. V akútnej situácii zvyčajne nie je čas na jej zasadnutie. Pri opakujúcich sa konfliktoch, pri ukončení dlhodobej liečby či pri rozpore medzi tímom a rodinou však môže mať zmysel. Rovnakú funkciu môže plniť aj neformálna konzultácia

so skúseným kolegom alebo konzílium. Etický kódex ukladá požiadať o konzílium vždy, keď si to okolnosti vyžadujú a pacient s tým súhlasí [3].

> **Meradlo po udalosti**
> Vedeli by sme obhájiť celý postup, keby sme nepoznali výsledok? Ak áno, výsledok nás môže zarmútiť, ale nemal by nás obviniť.

15. Metafyzické jadro: komu patrí život a čo je smrť pre medicínu

15.1 Telo ako hranica

Telo je miesto, kde sa stretáva medicína so slobodou. Pre lekára je telo predmetom vyšetrenia a liečby. Pre pacienta je to on sám. Fenomenológia, ktorú sme v prvom diele spomenuli v súvislosti s Husserlom a Merleau-Pontym, rozlišuje telo ako vec medzi vecami a telo, ktoré človek prežíva zvnútra. Nemecká terminológia na to má dve slová, Körper a Leib. Medicína pracuje najmä s prvým. Pacient žije v druhom.

Keď pacient odmieta dialýzu, nehovorí iba o fyziológii. Hovorí o tom, čo chce so svojím životom urobiť. Ústava chráni nedotknuteľnosť osoby [4, čl. 16]. Zákon chráni telesnú a psychickú integritu [1, § 11 ods. 9 písm. a)]. Metafyzicky to znamená, že telo nie je vecou, ktorú môže ktokoľvek iný spravovať v mene vyššieho dobra. Ani v mene života.

15.2 Vlastníctvo, dar, úloha

Štvrtý diel sa pýtal, komu patrí život, a odpovedal, že slovo vlastníctvo je zvodné, ale neúplné. Existujú najmenej tri metafory. Život ako vlastníctvo zdôrazňuje právo rozhodovať. Život ako dar zdôrazňuje vďačnosť a zodpovednosť voči jeho zdroju. Život ako úloha zdôrazňuje, že ho treba žiť, nie iba mať. Každá z týchto metafor niečo zachytáva a niečo vynecháva.

Pre medicínu je dôležité, že ani jedna z nich nedáva lekárovi oprávnenie rozhodovať za pacienta. Ak je život vlastníctvom, patrí pacientovi. Ak je darom, je darom jemu. Ak je úlohou, plní ju on. Lekár môže pomáhať, upozorňovať, varovať. Nemôže žiť život za iného.

15.3 Smrť ako horizont

Heidegger opisoval ľudskú existenciu ako bytie k smrti: smrť nie je iba udalosť, ktorá nás raz postihne, ale možnosť, ktorá štruktúruje celý náš život. Medicína má sklon chápať smrť ako nepriateľa, ktorého treba čo najdlhšie odďaľovať. To je správne, pokiaľ odďaľovanie slúži životu. Keď začne slúžiť iba odďaľovaniu, stráca zmysel.

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých nám pripomínajú, že smrť patrí k ľudskému životu. Nie je to výzva k rezignácii. Je to pozvanie pozerať sa na liečbu z perspektívy celého života, nielen z perspektívy najbližšej hodiny.

15.4 Poznanie, ktoré sa musí vzdať nadradenosti

Tretí diel o gnóze sa končil myšlienkou, že najzrelšie poznanie nie je to, ktoré všetko prekuklo, ale to, ktoré si zachováva vedomie vlastnej omylnosti. Hodnotná gnóza by podľa neho nemala človeka robiť nedotknuteľným voči otázkam, ale slobodnejším voči klamu. Pre medicínu je to presná lekcia. Odborné poznanie je skutočné a často zachraňuje životy. No keď sa začne považovať za mieru druhých, mení sa na moc bez kontroly. Lekár, ktorý vie, čo by pomohlo, ešte nevie, čo je pre pacienta dobré v celom jeho živote.

15.5 Duchovné výklady a ich nebezpečenstvo

Ezoterické tradície, ktoré sme mapovali v prvom diele, ponúkajú výklady utrpenia a smrti, ktoré môžu byť pre niektorých pacientov aj lekárov zdrojom útechy. Hnutie Grálu hovorí o nemenných zákonoch stvorenia, podľa ktorých sa každé konanie vracia k svojmu pôvodcovi. Teozofia hovorí o karme. Druhý diel však varoval pred duchovným obchádzaním: pred používaním duchovných vysvetlení na vyhýbanie sa bolesti, konfliktu alebo zodpovednosti.

Výrok, že pacient „si to priťahuje“ alebo že jeho choroba je „lekcia“, môže umlčať potrebnú pomoc a preniesť vinu na trpiaceho.

Pri hraniciach medicíny platí dvojitá poistka. Duchovný výklad nesmie ospravedlniť ukončenie starostlivosti, ktorú pacient chce. A nesmie ani ospravedlniť nátlak na pacienta, ktorý ju nechce. Ak pacient sám hľadá zmysel vo svojej viere, máme ho rešpektovať a podľa jeho želania mu sprostredkovať duchovnú službu. Ak ho nehľadá, nemáme mu ho vnucovať.

> **Filozofické východisko**
>
> Chrániť život, rešpektovať osobu a neopustiť trpiaceho sú tri záväzky, ktoré sa nedajú zlúčiť do jedného. Dobrá medicína drží všetky tri naraz, aj keď sa navzájom napínajú.

16. Rozhodovací kompas pri odmietnutí v akútnom zhoršení

Nasledujúci rámec dopĺňa štvorkrokový postup zo štvrtého dielu. Nie je slovenským právnym protokolom ani náhradou rozhodnutia v konkrétnej situácii. Má pomôcť nevynechať podstatnú otázku vtedy, keď na premýšľanie nie je veľa času.

Krok	Kľúčová otázka	Čo zaznamenať	Čomu sa vyhnúť
1. Naliehavosť	Čo hrozí, v akom čase a čo by zásah zmenil?	klinický stav, časový priestor, očakávaný účinok	strašeniu istotou, ktorú nemáme
2. Predmet nesúhlasu	Čo presne pacient odmieta a čo prijíma?	rozsah odmietnutia vlastnými slovami pacienta	zápisu „odmieta liečbu“ bez spresnenia
3. Spôsobilosť	Rozumie, oceňuje význam, zvažuje, vyjadruje voľbu?	konkrétne odpovede, prejavy delíria, liečiteľné príčiny	vyvodzovaniu neschopnosti zo samotného nesúhlasu
4. Bariéry	Čo sa dá zmeniť: bolesť, strach, doprava, prístup, hovoriaci?	čo sa ponúklo a s akým výsledkom	opakovaniu rovnakých argumentov
5. Právny základ	Máme súhlas, platné odmietnutie, alebo ide o výnimku podľa § 6 ods. 9?	ktorá situácia nastala a prečo	zámene naliehavosti za oprávnenie
6. Známa vôľa	Vyslovil pacient skôr konkrétne prianie?	obsah, čas, okolnosti, svedkovia	ignorovaniu aj automatickému zovšeobecneniu
7. Rodina	Koho pacient chce zapojiť a kto je oprávnený rozhodovať?	prítomné osoby, ich úloha, samostatný rozhovor	tomu, aby rodina rozhodovala namiesto pacienta
8. Pokračujúca starostlivosť	Čo poskytneme, ako budeme sledovať, kedy prehodnotíme?	plán liečby príznakov, kontakt, termín prehodnotenia	zápisu „nespolupracuje“ bez plánu
9. Tím a lekár	Potrebujeme druhého lekára, konzílium, podporu tímu?	koho sme prizvali a prečo	osamelému rozhodovaniu pod tlakom

17. Otázky na nedeľné premýšľanie

1. Ktorú z piatich hraníc medicíny najčastejšie zamieňam za inú?
2. Čo by ma presvedčilo, že pacientovo odmietnutie je slobodné, aj keď s ním nesúhlasím?
3. Keby pacient s rovnakými odpoveďami súhlasil, považoval by som ho za spôsobilého?
4. Kedy som naposledy presviedčal ďalej, hoci rozhovor už neprinášal nič nové?
5. Kedy som naopak ustúpil príliš skoro, pretože som bol unavený?
6. Je pre mňa ukončenie liečby ťažšie ako jej nezačatie? Prečo?
7. Čo by som potreboval vedieť o pacientovom živote, aby som pochopil jeho „nie“?
8. Aký morálny dlh majú blízki voči chorému a kde sa končí?
9. Ktorý duchovný alebo filozofický výklad mi pomáha zniesť smrť pacienta? Nepoužívam ho niekedy aj na to, aby som sa vyhol nepríjemnej otázke?
10. Čo pre pacienta ešte môžem urobiť, keď už nesmiem urobiť to, čo by som chcel?

18. Záver: hranica ako miesto stretnutia

Hranica medicíny nie je stena, za ktorou sa končí pomoc. Je to miesto, kde sa stretáva naše poznanie s cudzou slobodou, naša schopnosť s naším oprávnením a naša vôľa pomôcť s konečnosťou človeka, ktorému pomáhame. Na tomto mieste sa ukazuje, akú medicínu robíme.

Medicína, ktorá nepozná hranice, sa stáva mocou. Lieči telo aj proti človeku, ktorý v ňom žije, a víťazstvo nad chorobou zamieňa za dobro pacienta. Medicína, ktorá pozná iba hranice, sa stáva byrokraciou. Zapíše odmietnutie, podpíše reverz a odíde. Dobrá medicína je medzi nimi. Dôrazne vysvetľuje riziko, pozorne posudzuje rozhodovanie, poctivo pomenúva neistotu a vytrvalo hľadá to, čo pacient ešte prijme.

Slovenské právo dáva tomuto postoju pevnú oporu aj otvorené miesta. Pevná je požiadavka informovaného súhlasu, právo odmietnuť a právo súhlas odvolať. Pevný je aj zákaz eutanázie a asistovanej samovraždy. Otvorené zostávajú pokyny vopred, rozhodnutie neresuscitovať a trestnoprávna neistota lekára, ktorý rešpektuje odmietnutie. Kým zákonodarca tieto miesta nedoplní, ťarcha dopadá na kvalitu rozhodovania v jednotlivom prípade. Presné poučenie, poctivé posúdenie a dôkladný záznam nie sú byrokratická povinnosť. Sú formou rešpektu.

Na konci zostáva otázka, ktorou sa končil aj štvrtý diel: čo pre vás ešte môžeme urobiť? Neruší hranice. Zabezpečuje, aby sa hranica jedného zásahu nestala koncom ľudskej starostlivosti.

Keď sa skončí oprávnenie presadzovať určitú liečbu, nekončí sa povinnosť starať sa o človeka. A keď sa skončí možnosť predĺžiť život, nekončí sa možnosť zmierniť utrpenie.

19. Slovníček pojmov

Autonómia. Schopnosť a oprávnenie rozhodovať o sebe pri primeranej informovanosti, dobrovoľnosti a podpore. Nie je synonymom nezávislosti od iných.

Rozhodovacia spôsobilosť. Klinické posúdenie schopnosti porozumieť, oceniť význam pre seba, zvážiť možnosti a vyjadriť voľbu pri konkrétnom rozhodnutí v konkrétnom čase. Nie je totožná so spôsobilosťou na právne úkony.

Informovaný nesúhlas. Odmietnutie zdravotnej starostlivosti po poučení, ktoré zahŕňa aj riziká odmietnutia. Vyžaduje rovnakú kvalitu poučenia ako súhlas.

Neodkladná starostlivosť. Starostlivosť pri náhlej zmene stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo základné životné funkcie (§ 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.). Sama osebe nenahrádza súhlas.

Predpokladaný súhlas. Súhlas, ktorý možno rozumne predpokladať, ak ho nemožno včas získať. Nemožno ho predpokladať proti známemu informovanému odmietnutiu.

Skôr vyslovené prianie (pokyn vopred). Prianie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti vyslovené pre prípad, keď pacient nebude môcť rozhodovať. Podľa čl. 9 Dohovoru treba naň prihliadať.

Konzervatívna liečba zlyhania obličiek. Aktívna starostlivosť zameraná na kvalitu života bez dialýzy a transplantácie.

Časovo ohraničená skúška liečby. Dohodnuté obdobie liečby s vopred určeným cieľom a termínom prehodnotenia, z ktorého možno vystúpiť.

Eutanázia. Úmyselné podanie smrtiacej látky alebo zásah, ktorým lekár spôsobí smrť pacienta na jeho žiadosť. V Slovenskej republike neprípustná.

Pasívna eutanázia. Nepresný súhrnný pojem, ktorý zlučuje odlišné situácie. Tento spis odporúča nahradiť ho presným opisom výkonu, indikácie, vôle, zámeru a pokračujúcej starostlivosti.

Princíp dvojitého účinku. Etické rozlíšenie medzi zamýšľaným cieľom a predvídaným, ale nechceným následkom konania.

Morálna úzkosť. Stav, keď zdravotník vie, čo by bolo správne, ale vonkajšie obmedzenia mu bránia tak konať.

Duchovné obchádzanie. Používanie duchovných vysvetlení na vyhýbanie sa bolesti, konfliktu alebo zodpovednosti.

20. Pramene a poznámka k overeniu

20.1 Ako boli pramene overené

Slovenské právne predpisy boli overené 24. októbra 2026 v časových verziách zverejnených na portáli Slov-Lex, ktoré boli k tomuto dňu účinné. Pri každom predpise je uvedená použitá časová verzia. Medzinárodné dokumenty a odborná literatúra boli overené podľa vydavateľských stránok a databáz. Pri knihách, ktorých úplný text nebol prístupný, overenie znamená kontrolu bibliografických údajov a vecnej relevantnosti, nie preštudovanie celého diela. Slovenské formulácie sú parafrázami, ak nie sú označené úvodzovkami. Číslo v hranatých zátvorkách odkazuje na položku zoznamu.

20.2 Slovenské právne predpisy

[1] Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia účinná od 1. 8. 2026 do 30. 12. 2026. Najmä § 2 ods. 3 a 39, § 4 ods. 3 a 4, § 5, § 6, § 6ba, § 9 ods. 5, § 10e a § 11 ods. 9. https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2004/576/ZZ_2004_576_20260801.pdf

[2] Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Časová verzia účinná od 18. 8. 2026. Najmä § 28, § 29, § 144, § 145, § 149, § 154, § 177, § 207 a § 208. https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2005/300/ZZ_2005_300_20260818.pdf

[3] Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, príloha č. 4: Etický kódex zdravotníckeho pracovníka. Časová verzia účinná od 1. 8. 2026 do 31. 12. 2026. https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2004/578/ZZ_2004_578_20260801.pdf

[4] Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Časová verzia účinná od 1. 11. 2025. Najmä čl. 7 ods. 5, čl. 15 a čl. 16. https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/1992/460/ZZ_1992_460_20251101.pdf

[5] Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 40/2000 Z. z. o Dohovore o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovor o ľudských právach a biomedicíne). Najmä čl. 5, 6, 8 a 9. https://static.slov-lex.sk/pdf/SK/ZZ/2000/40/ZZ_2000_40.pdf

20.3 Slovenská odborná literatúra a správy

[6] Laciaková L, Kováč P, Moravanský N. Predchádzajúce prianie a prianie nebyť resuscitovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky. Via practica. 2017;14(4):208–213. https://www.solen.sk/storage/file/article/f903dbad1527526b79e99aa95e3de57b.pdf

[7] STVR. Na Slovensku chýbajú zákony, ktoré by umožnili realizovať priania pacientov na sklonku života. 7. 4. 2026. https://spravy.stvr.sk/2026/04/na-slovensku-chybaju-zakony-ktore-by-umoznili-realizovat-priania-pacientov-na-sklonku-zivota/

20.4 Medzinárodné etické dokumenty a rozhodnutia

[8] World Medical Association. Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide. Tbilisi, 2019. https://www.wma.net/policies-post/declaration-on-euthanasia-and-physician-assisted-suicide/

[9] World Medical Association. Declaration of Venice on End of Life Medical Care. Revízia 2022. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-venice-on-end-of-life-medical-care/

[10] World Medical Association. Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-lisbon-on-the-rights-of-the-patient/

[11] Európsky súd pre ľudské práva. Pretty proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 2346/02, rozsudok z 29. 4. 2002; Lambert a ďalší proti Francúzsku [VK], sťažnosť č. 46043/14,

rozsudok z 5. 6. 2015. Prehľad súdu k téme eutanázie a ukončenia liečby. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs_euthanasia_eng

20.5 Klinické odporúčania

[12] NICE NG108. Decision-making and mental capacity. 2018. Britský právny kontext nemožno zamieňať za slovenský. https://www.nice.org.uk/guidance/ng108

[13] Renal Physicians Association. Shared Decision-Making in the Appropriate Initiation of and Withdrawal from Dialysis. 2. vydanie, 2010. Americký odborný rámec, nie slovenský právny protokol.

[14] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/kdigo-2024-ckd-guideline/

[15] Davison SN a kol. Conservative kidney management and kidney supportive care: core components of integrated care for people with kidney failure. Kidney International. 2024;105. https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.001

20.6 Filozofická a etická literatúra

[16] Appelbaum PS. Assessment of patients' competence to consent to treatment. New England Journal of Medicine. 2007;357(18):1834–1840.

[17] Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8. vydanie. New York: Oxford University Press, 2019.

[18] Jameton A. Nursing Practice: The Ethical Issues. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984.

[19] Epstein EG, Hamric AB. Moral distress, moral residue, and the crescendo effect. Journal of Clinical Ethics. 2009;20(4):330–342. https://doi.org/10.1086/JCE200920406

[20] Rachels J. Active and passive euthanasia. New England Journal of Medicine. 1975;292(2):78–80.

20.7 Predchádzajúce diely a texty autora

[21] Polaščín Ľ. Ohrozenie života samo súhlas nenahradí. Substack, 24. 10. 2026; slovenská verzia aj na polascin.net. https://polascin.substack.com/p/ohrozenie-zivota-samo-suhlas-nenahradi

[22] Polaščín Ľ. Nedeľná metafyzika: Metafyzika 1 (Ontológia, epistemológia, vedomie; 27. 9. 2026), Metafyzika 2 (Vedomie, skutočnosť a hranice poznania; 4. 10. 2026), Metafyzika 3 (Gnóza a gnosticizmus; 18. 10. 2026), Metafyzika 4 (Hranice pomoci, autonómia a dôvera v medicíne; 25. 10. 2026). https://polascin.net/library.php

[23] Polaščín Ľ. O Čeresaroch. Etnografický, jazykový a miestnohistorický rešerš (1. 10. 2026); Generácie: vznik, pomenovania, charakteristiky a medzigeneračné vzťahy (17. 10. 2026).

Redakčná poznámka

Text prešiel slovenskou jazykovou korektúrou, kontrolou terminológie a nadväznosti na predchádzajúce diely. Neobsahuje skryté znaky ani vodoznaky. Klinické postupy sú odbornou syntézou, nie slovenským právnym protokolom. Právne pasáže nie sú právnym stanoviskom pre konkrétny prípad. Modelové situácie neoznačujú konkrétnych pacientov.